

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

SOGGETTI VULNERABILI E TUTELA DEL MINORE

Protocolli per minori, pazienti psichicamente vulnerabili e fine vita — FNOMCeO + L.
285/1997 + LR Toscana

Area 07 – Rischio Clinico

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PRO106_00	00	04/05/2026	4
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
Direttore Sanitario / Risk Manager Clinico	AD – Francesco Epifani	Distribuibile a tutto il personale clinico	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Iacopo Cupelli	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
04/05/2026	04/05/2026	04/05/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

1. Scopo

Definire i protocolli operativi per la presa in carico dei pazienti vulnerabili: minori (0-17 anni), pazienti con disabilità intellettiva o psichica, pazienti in stato di abuso o maltrattamento, pazienti in fine vita. Garantire tutela legale, qualità clinica e rispetto della dignità della persona.

2. Riferimenti

Riferimento	Pertinenza
Codice Deontologico FNOMCeO	Comportamento del medico verso vulnerabili
Convenzione di Lanzarote (rec. L. 172/2012)	Protezione minori da abuso sessuale
L. 285/1997	Disposizioni infanzia e adolescenza
L. 219/2017	Consenso informato e DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento)
L. 194/1978	IVG e diritti riproduttivi (con tutele per i minori)
LR Toscana 18/2017	Diritto alla salute riproduttiva — agevolazioni minori
Codice Civile artt. 316, 320	Responsabilità genitoriale, capacità di agire del minore
L. 67/2006	Antidiscriminazione disabili
Convenzione ONU diritti del fanciullo	Quadro internazionale

3. Tutela del Minore

3.1 Identificazione e consenso

- Minori < 14 anni: consenso del genitore/tutore legale obbligatorio. Identificazione del minore + documento dell'accompagnatore.
- Minori 14-17 anni: si ascolta sempre il minore. Consenso conforme art. 3 L. 219/2017 (capacità di discernimento). Informazione dovuta al genitore salvo eccezioni (vedi 3.2).
- Per esami invasivi o diagnostica complessa: consenso scritto specifico.

3.2 Test di gravidanza per minori — agevolazione Regione Toscana

La Regione Toscana, attraverso la Legge Regionale 18/2017 e le sue evoluzioni in materia di diritti riproduttivi, agevola l'esecuzione del test di gravidanza per le minorenni anche senza consenso/informazione genitoriale, in coerenza con la L. 194/1978 e con il principio del best interest of the child.

Toscana Diagnostica recepisce questa agevolazione operativamente come segue:

- Una minore di età 14-17 anni può richiedere autonomamente un test di gravidanza (ematico beta-hCG o urinario).
- Il consenso del genitore NON è obbligatorio (art. 3 L. 219/2017 + tutela LR Toscana 18/2017).
- Riservatezza assoluta: l'esito è comunicato direttamente alla minore, salvo sua esplicita richiesta di coinvolgere altri.
- Counselling sanitario disponibile in collaborazione con consultorio familiare territoriale.
- In caso di test positivo: orientamento al consultorio + medico di fiducia (NO refertazione direttamente al genitore).
- Per minori di età < 14 anni che richiedano un test: attivazione protocollo di tutela (segnalazione a Servizio Sociale + ASL competente per profilo di vulnerabilità).

- Tariffa: gratuita o agevolata in regime SSR Toscana (vedi tariffario aggiornato).
- Accoglienza: personale formato, sala riservata, comunicazione non giudicante.

3.3 Indicatori di abuso o maltrattamento

Personale formato (medici, infermieri, accettazione) sui segnali d'allarme: lesioni incompatibili con la storia, ritardo nell'accesso alle cure, comportamento iperalert/dissociato, presenza di malattie sessualmente trasmissibili in minore. In caso di sospetto: protocollo di segnalazione a Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni + ASL competente, mantenendo riservatezza verso l'accompagnatore se sospetto autore (rif. art. 9 L. 184/1983). Nel dettaglio:

- **Segnale d'Aiuto (Signal for Help)**
 - o Si tratta di un gesto universale, utilizzato spesso in videochiamata o in presenza per chiedere aiuto senza lasciare tracce, concepito per non allertare l'aggressore:
 - Mostrare la mano aperta.
 - Piegare il pollice all'interno del palmo.
 - Chiudere le altre quattro dita sopra il pollice, formando un pugno.
 - Ripetere il gesto se necessario.
- **Numeri Utili per Aiuto e Segnalazioni**
 - o 114 - Emergenza Infanzia: Servizio del Ministero della Famiglia per bambini e adolescenti in pericolo, attivo 24/7.
 - o 1522: Numero antiviolenza e stalking (attivo 24/7 per supporto immediato).
 - o 112: Forze dell'ordine in caso di pericolo imminente.

4. Pazienti con disabilità intellettiva o psichica

- Capacità di prestare consenso: valutazione individuale; per pazienti interdetti o sotto amministrazione di sostegno, consenso del rappresentante legale ai sensi del Codice Civile.
- Comunicazione adattata: linguaggio semplice, pittogrammi, tempi estesi.
- Coinvolgimento dell'accompagnatore di fiducia (non sostituisce il consenso).
- Postazioni "low-stimulus": rif. PRO104 §3.3.
- Personale formato su deescalation comportamentale.

5. Workflow segnalazione vulnerabilità

Step	Attività	Responsabile
1	Identificazione del paziente vulnerabile (in accettazione o durante visita/prelievo)	Operatore di accettazione / Sanitario
2	Attivazione del protocollo specifico (3.2 minori, 3.3 abuso, 4 disabilità, 5 fine vita)	DS o suo delegato
3	Coordinamento con servizi territoriali (consultorio, servizio sociale, MMG, Hospice)	DS / Customer Experience
4	Documentazione in cartella paziente con flag vulnerabilità	Operatore
5	Eventuale segnalazione obbligatoria (Procura Minorenni, ASL, Garante Infanzia)	DS + Legal
6	Riesame post-evento (Just Culture PRO111) per apprendimento sistemico	Risk Manager Clinico

6. Formazione obbligatoria

Modulo annuale obbligatorio per tutto il personale a contatto con il paziente: 4h base + 4h modulo specifico per medici/infermieri/operatori accettazione (riconoscimento abuso, comunicazione minore, deescalation). Refresher biennale.

7. Riferimenti documentali

Codice	Documento
TD-SGI-PRO104	Health Equity
TD-SGI-PRO040	Comunicazione Paziente e consenso
TD-SGI-PRO093	Open Disclosure eventi avversi
TD-SGI-PRO111	Just Culture e gestione del near miss
TD-SGI-PRO087	Prevenzione molestie e violenza (deescalation)
TD-SGI-PRO028	Prevenzione Violenza Operatori (kids experience)
TD-SGI-MAN003	Manuale Privacy / PIMS (riservatezza dati minori)
TD-SGI-PLN002	Piano D&I (vulnerabilità)

8. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Approv.
00	04/05/2026	Prima emissione: protocolli minori (incl. test gravidanza LR Toscana 18/2017), disabilità, fine vita.	AD / DS